



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : هاله فتحى على صالح

العنوان : 38 ش عبدالحميد محمود
هلال

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 26402130104087 رقم التليفون : 01223540651

العمر (تاريخ الميلاد) : 13-02-1964 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاله فتحى على صالح National ID: 26402130104087	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

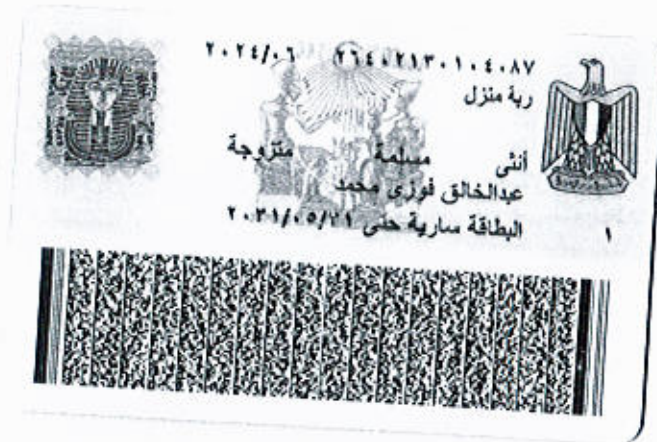
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Dms
فرعون

١١٢٩٤٧٧٥٠





Presidential Program to Witness Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي ليشهد الصحة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name : محمد النور علي

Sex:

MDT form

3- Medical numbers:

Female

53210654

Old Med :

Voting

2270-2024

2-ID number:

Patient Age : 61 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01202444293

BMI

BMI

REASON OF MDT

Reason of MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

ADJ

Date of MDT

Date of MDT

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

05/11/2024

Clinical data

Breast Imaging :

lc breast UOQ mass with suspicious microcalcifications
U/S: bilateral mass at 2 o'clock 2.5 mm deep to skin 2.8 x 1.8 cm
at 12 o'clock subcutaneous lesion 10 x 6 mm
at 1 o'clock lesion 6 x 4 mm 1 cm from nipple
non specific axillary Ln

Mets Workup :

ct capisterium L1 L2 sclerotic foci
PAUS : free

BX

IOC

BX COMMENTS

gli with focal dcis

ER

0/0

ER COMMENTS

PR

4/8

PR COMMENTS

Her 2 Neu

0

Her 2 Neu COMMENTS

SISH

SISH

SISH COMMENTS

Ki67

Ki67

Ki67 COMMENTS

T

2

N

0

M

0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt underwent upfront surgery

BCS, T2 N0

LT WLE+SLN: free margin

LN 0/6

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

4 Cycles DC (DOCETAXEL-CYCLOPHOSPHAMIDE)

PORT

AT FOR 5 years

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

Patient Name	: الأستاذة / ماله فتحي على صالح	Request No.	: 13008459
Patient No.	: 26402130104087	Request Date	: 15/05/2024
Path No.	: 1598/24	Verification Date	: 19/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: تأمين الدولة - نفقة الدولة
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 15/05/2024, 10:15 am.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores, up to 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Focally detected.
- * Perineural Invasion: Not detected.
- * Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, With focal DCIS.
For further IHC (ER, PR, He-2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Atty.
Dr. Esraa Magdy.

الرئيسية
والطوارئ

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 10/06/2024 11:46:10

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



شركة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / ماله فتحى على صالح	Request No.	: 13006017
Patient No.	: 26402130104087	Request Date	: 05/10/2024
Path No.	: 3785/24	Verification Date	: 21/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: Out Patient
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Left breast, WLE and SLNs Biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with focal DCIS.
Free margins.
Free Lymph nodes (0/12).
Stage: pT2, pN0.

Signature
Prof. Dr.Gamal Abdelatty.
Dr.Menna Nabil.

Verified by :
Dr. Sagda El-Kady

Printing Date : 21/10/2024 10:59:50

Page 2 of 2

Printing By : mervat mohamed

CAP
ACCREDITED

شركة زقة (م) - مصر - القاهرة - معمل الباثولوجي - معمل الباثولوجي - معمل الباثولوجي
Room No. (4) • First Floor • Building No. 987 • Nile Corniche • 11561 • Giza • Egypt

Patient Name :
Patient No. : 26402130104087
Path No. : 1598/24
Sex : Female
Age : 60 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13008459
Request Date : 15/05/2024
Verification Date : 26/05/2024
Financial Category : Out Patient
Department :
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 15/5/2024

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) and Ki67 clone (30-9).

Results:

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity).
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 4 % tumor cells (Allred score 4/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, with focal DCIS.
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 4/8).
Her2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Verified by :
Dr. Hiba Hasan

Signature

Printing Date : 10.06/2024 11:46:16

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youssef



Room No. (1) - First Floor - Building No. 527, Nile Corniche - Mar El Qadima - Cairo, Egypt
مركز الهرم - الدور الأول - مبنى رقم (527) - كورنيش النيل - القاهرة - مصر

Patient Name: الأستاذة / هبة هاشم علي صليح
Patient No: 26402130104087
Path No: 1598/24
Sex: Female
Age: 60 Y
Referring Doc:

Request No: 13008459
Request Date: 15/05/2024
Verification Date: 26/05/2024
Financial Category: كود التأمين - طبعة الدولة
Department: Out Patient

Registered by: marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Prof Dr. Gamal Abdelatty
Dr. Toka Medhat

Verified by:
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 10/06/2024 11:46:16

Page 2 of 2

Printed By : marwa mohamed youssef



غرفة رقم (11) - الدور الأول - مبنى رقم (2871) - اوراشين هيل - مقرر الطبعة - القاهرة - مصر
Room No (11) - First floor - Building No. 2871 - Nile Corniche - Mir El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name :
Patient No. : 26402130104087
Path No. : 1598/24
Sex : Female
Age : 60 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008459
Request Date : 15/05/2024
Verification Date : 19/05/2024
Financial Category : Out Patient
Department :
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 15/05/2024, 10.15 am.

Gross Examination:

• Multiple grayish white tissue cores, up to 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- Ductal carcinoma in situ: Focally detected.
- Perineural invasion: Not detected.
- Angiolymphatic invasion: Not detected.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, With focal DCIS.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aziz
Dr. Esraa Magdy.

البريد الإلكتروني
Dr. Esraa Magdy

Verified by:
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 10/06/2024 11:46:10

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



Room No. (4) - First Floor - Building No. 287, Nile Corniche - Micro El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name: Hala Fat'hy Ali Saleh	Date : 20/07/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 60 Year(s)
Medical ID: 2270/2024	Pat ID: 76519

**NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Left breast irregular mass lesion measuring 2.5 x 3.2 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses or consolidative patches.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Cardiomegaly. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & contour of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows osteopenic texture of the examined bones with sternum and few vertebral bodies subtle lucent areas as well as L1 and L2 upper vertebral end plates sclerotic foci.
- Mild anterior wedging of L4 vertebral body.

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer
Radiology Department

وزارة الصحة
مراكز الرعاية الطبية المتخصصة
دار السلام للسرطان
إدارة الأشعة

Patient Name: Hala Fathy Ali Saleh	Date : 20/07/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 60 Year(s)
Medical ID: 2270/2024	Pat ID: 76519

OPINION:

- Left breast malignant looking mass lesion.
- osteopenic texture of the examined bones with sternum and few vertebral bodies subtle lucent areas as well as L1 and L2 upper vertebral end plates sclerotic foci for bone scan.
- No pulmonary or hepatic metastatic deposits on noncontrast basis.

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Signature Prof. Menna Taha Hany
20/07/2024 02:34



Nuclear Medicine Unit

Patient Name: Hala Fatehy Ali

Date: 9/1/2024

Referring physician: Dr. MDP BONE SCAN

Desired Information: skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole-body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

- Solitary abnormal, focal active osseous lesion is seen at left 4th rib anteriorly likely of worrying nature. for CT contrasted study correlation, close follow up.
- Other wise, no definite hot spot that could account for osseous metastatic deposits.
- Spondylodegenerative changes are seen at the dorso lumbar spine.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

Solitary active focal osseous rib lesion is seen left 4th rib, of worrying nature for CT contrasted study correlation, follow up.

Other wise, no definite osseous metastatic lesion could be seen all over the surveyed body.

Thanks for the referral

Nuclear Medicine Unit

DR. Sherin Mahdy, MD

DR Mohamed Emara